



Soins attentifs pour chaque nouveau-né



Lorsque les nourrissons reçoivent des soins dans un environnement attentif, cela leur permet non seulement de survivre, mais également de s'épanouir. Cependant, trop de nourrissons sont privés de leur droit de recevoir des soins attentifs, notamment lorsqu'ils ont besoin de recevoir des soins en services internes.

Chaque année, on estime que 140 millions de nourrissons naissent, et parmi ceux-ci, environ 30 millions ont besoin de soins en services internes et 8 à 10 millions nécessitent des soins intensifs néonataux (1). Depuis 1990, la mortalité néonatale dans le monde a diminué de plus de moitié, mais en 2019, on estimait que 2,4 millions de nouveau-nés mouraient encore au cours du premier mois suivant la naissance (2). Les nourrissons qui naissent prématurément, qui ont un faible poids de naissance ou qui

présentent des complications à la naissance sont les plus à risque, non seulement de décès, mais également de handicap à vie. Les progrès en matière de réduction de la mortalité néonatale seront compromis si des investissements ne sont pas également réalisés en faveur des soins attentifs.

La naissance est une transition cruciale pour chaque nouveau-né, qui sort alors de l'utérus nourricier pour recevoir des soins dans le monde extérieur. Les soins essentiels au nouveau-né comprennent le contact peau à peau immédiat, le maintien de la chaleur, des soins hygiéniques, un allaitement maternel précoce et exclusif et le maintien du nouveau-né en permanence avec la personne qui s'en occupe, ou « zéro séparation ». Ils visent à rendre cette transition aussi harmonieuse que possible et à offrir au nourrisson un environnement attentif dans les premières minutes et les premières heures après la naissance, nécessaire à la croissance et au développement du cerveau et du corps (3).

Que sont les soins attentifs ?

Le déroulement de la petite enfance (de la grossesse à l'âge de 8 ans) conditionne le reste de la vie. Nous avons fait de grands progrès en termes de survie de l'enfant, mais nous devons également créer les conditions permettant aux enfants de s'épanouir à mesure qu'ils grandissent et qu'ils se développent. Il faut pour cela donner aux enfants des soins attentifs, en particulier au cours des premières années (de la grossesse à l'âge de 3 ans).

Les soins attentifs comprennent cinq éléments interdépendants et indivisibles : une bonne santé, une nutrition adéquate, la sûreté et la sécurité, la prestation de soins adaptés et des possibilités d'apprentissage précoce. Les soins attentifs protègent les enfants des pires effets de l'adversité et ont des bienfaits à vie et pour plusieurs générations en termes de santé, de productivité et de cohésion sociale.

Les soins attentifs sont possibles si on optimise au maximum chaque interaction avec un enfant. Chaque moment, court ou long, structuré ou non, est l'occasion de s'assurer que les enfants sont en bonne santé, consomment des aliments nutritifs, sont en sécurité et apprennent à se connaître, à connaître les autres et à se familiariser avec le monde qui les entoure. Ce que nous faisons est important, mais la façon dont nous le faisons est plus importante encore.

Une mère et un père pratiquent le contact peau à peau. © Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant/Isabel Pinto

Cette note thématique résume les raisons pour lesquelles les soins attentifs sont essentiels pour chaque nouveau-né. Elle présente les cinq composantes des soins attentifs et contient des exemples d'actions pratiques visant à créer et à renforcer des environnements attentifs pour les nouveau-nés, y compris les nouveau-nés prématurés, de petits poids ou malades.

Le premier mois de vie est primordial pour permettre aux enfants de bien démarrer leur parcours vers l'atteinte de leur plein potentiel. Les responsables politiques, les responsables des soins de santé, les prestataires de soins et les parents peuvent mener la transformation nécessaire pour que chaque nouveau-né prenne le meilleur départ possible dans la vie. Dans cette note thématique, six études de cas illustrent différentes manières de procéder pour créer un environnement favorable et permettre aux personnes s'occupant de nouveau-nés de leur prodiguer des soins attentifs, d'abord au sein de l'établissement de santé puis à domicile.

Importance des soins attentifs pour permettre aux nouveau-nés de survivre et de s'épanouir

Le neurodéveloppement commence pendant la grossesse et s'accélère rapidement après la naissance.

Après 28 semaines de gestation, le fœtus en développement entend et, dès la naissance, les nourrissons reconnaissent la voix de leur mère. Les connexions synaptiques s'établissent dans le cerveau à une vitesse extraordinaire au cours des premiers jours et des premières semaines après la naissance, constituant les premières étapes du développement des fonctions sensorielles qui seront présentes tout au long de la vie telles que l'ouïe, la vue, la parole et la compréhension de l'environnement. Pour que cela se produise, le cerveau des nouveau-nés doit recevoir des stimuli appropriés grâce à leur interaction étroite avec les personnes qui s'occupent d'eux et grâce à leur environnement, dès les premiers moments suivant la naissance. Lorsque les nourrissons reçoivent des

Faits et chiffres

Dans le monde, plus de

80 %

des naissances ont lieu dans un établissement de santé avec une personne qualifiée pour la pratique des accouchements (4).



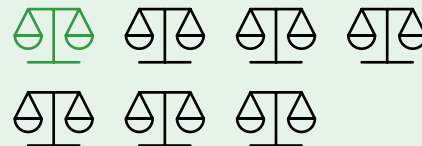
Un nourrisson sur dix naît avant terme (5).

Les causes directes de décès sont la prématurité, les complications à la naissance, le sepsis néonatal et les anomalies congénitales.

On estime que

2,4 millions

de nouveau-nés meurent chaque année, principalement de causes évitables (2).



Un nourrisson sur sept naît avec un faible poids de naissance (6).

L'insuffisance pondérale à la naissance contribue à une proportion allant de 60 à 80 % de l'ensemble des décès néonataux (7).

soins prodigués avec amour par leurs parents et par les autres personnes qui s'occupent d'eux, ils ont les meilleures chances de survivre et de s'épanouir, que ce soit au sein d'un établissement de santé ou à domicile. À l'inverse, lorsque les nouveau-nés sont privés de tels soins, par exemple en raison de la séparation avec les personnes qui s'occupent d'eux ou de l'exposition au stress ou à la douleur, ils deviennent plus vulnérables, et sont exposés à un risque accru de décès ou de handicap, notamment des troubles de l'apprentissage, de la vision et de l'audition. Par conséquent, les soins attentifs sont vitaux pour chaque nouveau-né (1).

Au cours de la grossesse, les soins attentifs sont soutenus par un minimum de huit visites prénatales avec des personnels de santé. Chaque visite constitue une occasion de donner des conseils à la femme enceinte et à sa famille sur l'adoption d'une alimentation saine, la prévention du tabagisme et de la consommation de substances psychoactives, la préparation de la naissance et la promotion de l'allaitement, et permet également d'apporter un soutien en matière de santé mentale. Les soins prénatals optimaux comprennent une supplémentation en fer et en acide folique, une échographie précoce, si possible, afin d'estimer l'âge

gestationnel et une identification et une prise en charge précoces des facteurs de risque d'accouchement prématuré, y compris les infections (8).

Des soins de haute qualité lors de l'accouchement donnent à la mère la possibilité de prodiguer des soins attentifs à son nouveau-né. Ils consistent notamment à permettre la présence d'une personne choisie pour l'accompagner et à éviter des interventions inutiles, par exemple une césarienne. Des données probantes démontrent qu'une expérience traumatisante lors de l'accouchement peut avoir une incidence sur la capacité d'une mère à établir des liens avec son enfant et accroître le risque de dépression périnatale. Afin de soutenir les soins attentifs, un aspect clé consiste à veiller à ce que chaque femme enceinte ait une expérience positive de l'accouchement, ce qui nécessite souvent le recours à des soins prodigués par des sages-femmes (9).



Une mère veille sur son nourrisson endormi au Bangladesh. © USAID/Amy Cotter

Au cours du premier mois de vie, il est important de soutenir les cinq composantes des soins attentifs pour chaque nouveau-né.

Une bonne santé implique la prévention et la prise en charge des maladies, y compris la prestation de soins de haute qualité fondés sur des données probantes pour les nouveau-nés malades ou de petit poids.

Une nutrition adéquate signifie optimiser l'allaitement maternel exclusif, au sein ou par du lait tiré, notamment pour les nourrissons malades et de très petit poids.

La sécurité et la sûreté nécessitent le maintien de la chaleur, de bonnes pratiques d'hygiène, une limitation du stress et la possibilité pour la personne qui s'occupe du nourrisson à titre principal, le plus souvent la mère, de se trouver dans un environnement calme avec son enfant.

L'apprentissage précoce consiste à stimuler le cerveau du nourrisson en douceur, par le toucher, la voix ou simplement par un contact étroit.

Des soins répondant aux besoins signifient qu'il faut être attentif aux signaux du nouveau-né, qui peuvent être indicateurs de faim, de douleur ou de stress, et y répondre de manière appropriée.



Composantes des soins attentifs

BONNE SANTÉ



Il s'agit de la santé et du bien-être des enfants et des personnes qui s'occupent d'eux. Pourquoi ? On sait que la santé physique et mentale des personnes qui ont la garde d'enfants peut influencer sur leur aptitude à prendre soin d'eux.

NUTRITION ADÉQUATE



S'applique à la nutrition chez la mère et chez l'enfant. Pourquoi ? On sait que l'état nutritionnel de la mère pendant la grossesse a une incidence sur sa santé et son bien-être et sur ceux du fœtus. Après la naissance, l'état nutritionnel de la mère influe sur son aptitude à prodiguer à l'enfant les soins dont il a besoin.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ



Il est question de la sécurité et de la sûreté de l'environnement dans lequel vivent les enfants et leur famille : dangers physiques, stress émotionnel, risques environnementaux (pollution, p. ex.) et accès à l'eau et à la nourriture.

OPPORTUNITÉS POUR L'APPRENTISSAGE PRÉCOCE



Désigne toute occasion qu'a un bébé, un tout-petit ou un enfant d'interagir avec une personne, un lieu ou un objet dans son environnement. Chaque interaction (positive ou négative) ou l'absence d'interaction contribue au développement cérébral de l'enfant et pose les bases de l'apprentissage ultérieur.

SOINS RÉPONDANT AUX BESOINS



Désigne l'aptitude du parent ou de la personne s'occupant de l'enfant à déceler, comprendre et réagir aux signaux de l'enfant au moment voulu et de façon adaptée. Composante considérée comme fondamentale car des personnes réactives sont mieux à même de contribuer aux quatre autres composantes.

Créer un environnement attentif pour tous les nouveau-nés

Lorsque les prestataires de soins collaborent avec les familles pour prodiguer des soins attentifs, un plus grand nombre de nouveau-nés survivent et reçoivent de meilleurs soins au sein de l'établissement de santé et à domicile pour leur permettre de s'épanouir.

Un environnement attentif peut être mis en œuvre lorsque les services de soins maternels et néonataux sont organisés autour des principes fondamentaux de dignité et de respect, d'échange d'informations, de participation et de collaboration.

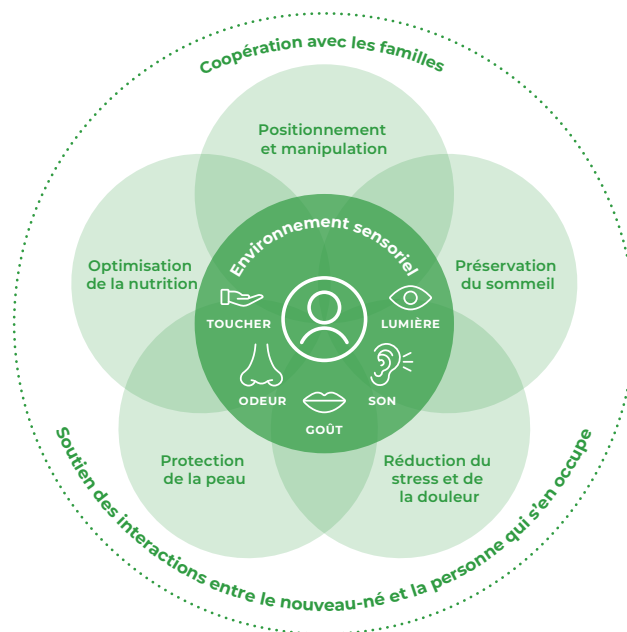
Une approche qui peut être employée est celle des soins de développement centrés sur le nourrisson et la famille (*infant- and family-centred developmental care*, IFCDC), qui créent un environnement attentif pour répondre aux besoins de chaque nourrisson et qui limitent l'influence de facteurs négatifs (Figure 1). L'approche IFCDC réduit le stress pour le nouveau-né et les parents, renforce l'établissement de liens affectifs, favorise l'alimentation et la croissance de l'enfant, soutient le neurodéveloppement de l'enfant, aide à prévenir les handicaps et facilite la sortie précoce de l'hôpital.

Les éléments de soutien du développement des soins aux nouveau-nés sont l'optimisation de la nutrition, le positionnement et la manipulation, la préservation du sommeil, la réduction du stress et de la douleur et la protection de la peau (9). Cette approche crée un environnement sensoriel pour répondre aux besoins de chaque nourrisson et limiter l'influence de facteurs négatifs. Elle est particulièrement importante pour les nourrissons de petit poids ou malades qui doivent recevoir des soins en services internes.

Prodiguer les soins essentiels précoces aux nouveau-nés

Les soins au nouveau-né commencent dans les premières secondes, minutes et heures après la naissance et comprennent la protection thermique, le contact peau à peau immédiat avec la mère, le maintien

Figure 1. Composantes des soins de développement centrés sur le nourrisson et la famille (9).



du nouveau-né en permanence avec la mère, ou « zéro séparation », même après une césarienne, l'identification des nouveau-nés de petit poids ou malades nécessitant des soins spéciaux, le démarrage précoce de l'allaitement maternel exclusif, au sein ou par du lait tiré, l'hygiène et le lavage des mains, les soins du cordon ombilical, le retardement du premier bain et la vaccination. Des données probantes montrent que l'application des pratiques recommandées de soins essentiels aux nouveau-nés réduit considérablement les risques de mortalité néonatale et favorise le neurodéveloppement (10).

Favoriser la participation des parents

La participation active de la famille aux soins du nouveau-né commence immédiatement après la naissance, avec le contact peau à peau entre la mère et le nouveau-né pendant au moins une heure après l'accouchement, par voie basse comme par césarienne. Ce contact établit un environnement physique et émotionnel pour la mère et le nourrisson qui favorise la stabilité physiologique et encourage l'établissement de liens affectifs. Au cours de ces moments privilégiés, de nombreux nourrissons commenceront à chercher le lait de leur mère et l'allaitement maternel précoce peut être démarré. Les pères ne doivent pas être oubliés en tant que parents égaux et, avec les autres membres de la famille, ils doivent être accompagnés et conseillés sur la manière de participer aux soins de leur nourrisson.

Mettre en œuvre les Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel

L'initiative Hôpitaux amis des bébés (11) et les Dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel soutiennent la mise en place d'un environnement attentif dans les services de maternité et donnent aux personnes s'occupant d'un nouveau-né la confiance et les compétences nécessaires pour lui prodiguer des soins attentifs.

Encourager l'allaitement maternel exclusif

L'importance du démarrage précoce de l'allaitement maternel exclusif pour la santé et le développement du nouveau-né ne saurait être surestimée. Le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires au cours des 6 premiers mois de vie de la plupart des enfants, y compris les nourrissons de petit poids ou malades et qui peuvent nécessiter une alimentation assistée, notamment une alimentation au gobelet et par sonde nasogastrique. L'allaitement maternel protège également contre les maladies infantiles courantes et réduit le risque de surpoids et d'obésité au cours de l'enfance et de l'adolescence. Pourtant, selon les estimations actuelles, seulement 42 % des nourrissons sont exclusivement allaités au cours de leurs 6 premiers mois de vie (4). Lorsque des nourrissons de petit poids ou malades ont besoin d'une alimentation d'appoint, il est recommandé d'utiliser du lait maternel provenant d'une donneuse qui peut être obtenu de manière sûre et abordable auprès d'un lactarium ; il peut être nécessaire de mettre en place ce type de structure.

INDE:

Déploiement à l'échelle nationale d'un modèle de soins impliquant une participation de la famille

Un modèle de soins centrés sur le nourrisson et la famille a été élaboré et évalué dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé mené dans une structure de soins tertiaires, l'unité de soins intensifs néonataux du Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr Ram Manohar Lohia Hospital, à New Delhi, en Inde. Un outil audiovisuel structuré et adapté à la culture a été élaboré pour permettre aux parents participant aux soins de prodiguer un ensemble limité de soins à leurs nouveau-nés malades au cours de l'hospitalisation. Cette approche a facilité la prestation des soins par le personnel, a amélioré les taux d'allaitement maternel et a réduit la durée d'hospitalisation, sans provoquer une augmentation des infections nosocomiales. Il a été déterminé que cette approche était réalisable et acceptable pour divers profils culturels, socio-économiques et démographiques de personnes s'occupant de nouveau-nés.

Le Ministère de la santé a mis à l'essai cette approche dans des structures de santé publique en 2014. Ayant constaté l'acceptabilité de cette innovation dans les structures, qui étaient prêtes à la mettre en œuvre, ce modèle de soins impliquant une participation de la famille (*Family Participatory Care*, FPC) a été approuvé pour un déploiement à l'échelle nationale. Des lignes directrices opérationnelles nationales et un programme de formation ont été publiés en 2017.

Une étude d'impact du modèle FPC menée dans 69 unités spéciales de soins néonataux de district a fait apparaître une série de pratiques positives. Dans les unités, une logistique favorable, une amélioration des compétences des prestataires, la participation des parents à la prestation de soins et un meilleur suivi après la sortie ont été observés. Dans le cadre des soins à domicile, on a constaté une augmentation de la pratique de la méthode « mère kangourou » (MMK) et des taux d'allaitement maternel exclusif, ainsi que des activités de jeu et de stimulation, et une amélioration de la détection des signes de danger et du recours aux soins. Il a été démontré que le modèle FPC améliore la qualité des soins aux nouveau-nés malades au sein des établissements, et que ce modèle a également amélioré les pratiques familiales et communautaires pour la survie, la croissance et le développement des enfants.

Références : Sarin E, Maria A. Acceptability of a family-centered newborn care model among providers and receivers of care in a public health setting: a qualitative study from India. *BMC Health Services Research*. 2019;19(1):184.

Verma A, Maria A, Pandey RM, Hans C, Verma A et al. Family-centered care to complement care of sick newborns: a randomized controlled trial. *Indian Pediatrics*. 2017;54(6):455-9.



Un nourrisson répond par un sourire au baiser affectueux de sa mère en Inde.

Promouvoir des soins répondant aux besoins et des activités d'apprentissage précoce

Lorsque les personnes s'occupant d'un nouveau-né le portent souvent dans les bras, établissent un contact visuel régulier et lui parlent ou chantent doucement, il devient plus facile pour elles d'observer les signaux de leur enfant et de les interpréter pour savoir s'il a faim ou s'il a sommeil. Le fait d'apprendre, avec l'aide des prestataires de soins, à reconnaître et à comprendre ces signaux, et à y répondre, aide les parents à se sentir plus en confiance et plus à même de continuer à répondre aux besoins en évolution du nouveau-né à la maison. Ce soutien peut être particulièrement important pour les nouveaux parents.

Soutenir la santé mentale des personnes s'occupant de nouveau-nés

Les parents de nouveau-nés peuvent être fatigués et dépassés et ne pas savoir comment s'occuper au mieux de leur enfant. Il est important de leur apporter un soutien, notamment en prêtant attention à leur santé mentale, car une femme sur six dans le monde présente des signes de dépression postnatale qui a une incidence sur sa capacité à s'occuper de son enfant (12). Tous les parents apprécient qu'on leur demande comment ils vont. Lorsque les prestataires de soins font preuve de capacités d'écoute empathique, ils peuvent donner des conseils simples et utiles pour tout problème émotionnel exprimé, comme se concentrer sur la relation avec le nourrisson, assurer une nutrition adéquate, dormir suffisamment, pratiquer la relaxation et de l'activité physique.

Fournir des soins postnatals après la sortie de l'établissement de soins

La poursuite des soins postnatals tout au long du premier mois est essentielle pour veiller à ce que la mère et le nourrisson restent en bonne santé sur tous les plans (physique, nutritionnel, mental et social). Après un accouchement par voie basse sans complications dans un établissement de soins, les mères et les nouveau-nés en bonne santé doivent recevoir des soins dans l'établissement pendant au moins 24 heures après la naissance. Au moins trois visites postnatales supplémentaires sont recommandées pour toutes les mères et tous les nouveau-nés, au jour 3 (48 à 72 heures), entre les jours 7 et 14 et six semaines après la naissance (13).

Des soins intégrés pour la mère et le nourrisson sont un élément clé, que ce soit à domicile ou en établissement de soins. Ces soins doivent inclure

l'évaluation des signes de maladie chez la mère et le nourrisson, une attention portée à la protection thermique, les soins du cordon ombilical et la vaccination, ainsi qu'un soutien de l'allaitement maternel exclusif. Les services de conseil en matière de soins répondant aux besoins, de communication et de jeu avec le nouveau-né, ainsi que l'évaluation et le soutien de la santé mentale maternelle sont deux éléments des soins postnatals qui sont essentiels mais parfois oubliés. Des visites de suivi supplémentaires peuvent être nécessaires pour les nouveau-nés qui ont présenté des complications ou qui sont nés dans des familles qui connaissent des difficultés.

Soins attentifs pour les nouveau-nés malades et de petit poids

Chaque année, environ 20 millions de nouveau-nés présentent un faible poids à la naissance (< 2500 g), dont 15 millions naissent prématurément (5).

En outre, on estime que 6,9 millions de nourrissons sont touchés par une infection bactérienne potentiellement grave, ou par un sepsis (14). La prématurité et le sepsis provoquent plus de la moitié des décès de nouveau-nés ; ils constituent les principales causes de décès néonataux, avec les événements intrapartum et les anomalies congénitales (4).

Les nouveau-nés prématurés ou qui présentent un poids de naissance trop faible, ou qui sont malades, sont plus vulnérables et ont besoin de soins supplémentaires. Il est préférable que ces soins soient prodigués directement par les parents, en étroite collaboration avec les personnels de santé. Environ deux tiers de ces nouveau-nés malades ou de petit poids n'ont pas besoin de soins intensifs, mais d'un soutien supplémentaire pour l'alimentation, le maintien de la chaleur et la prévention des infections, fourni dans un environnement attentif.

Promouvoir le « zéro séparation »

Les séparations inutiles entravent l'établissement de liens affectifs entre le nouveau-né et les parents, en particulier pour les nouveau-nés malades ou de petit poids. Les parents qui sont séparés de leur nourrisson sont plus susceptibles de ressentir de l'anxiété et de se sentir impuissants que ceux qui jouent un rôle actif dans

les soins de leur enfant. Le fait d'être ensemble leur permet d'apprendre à répondre aux besoins de leur nourrisson. Le contact constant avec la famille, avec le maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère et la possibilité de pratiquer le contact peau à peau, est la meilleure solution pour garantir que les parents sont pleinement en mesure de prodiguer des soins attentifs à leur nouveau-né à tout moment.

Mettre en œuvre des soins en services internes qui soutiennent le développement

Le milieu hospitalier influence l'expérience des soins pour les nouveau-nés et leur famille lorsque des soins en services internes sont nécessaires. Le nourrisson réagit aux stimuli sensoriels par des changements physiologiques de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène, ce qui peut avoir une incidence sur le développement du cerveau. Les stimuli tels que les lumières vives, le bruit et les interventions douloureuses peuvent être difficiles à supporter pour les nouveau-nés et avoir un impact négatif. Les stimuli appropriés à l'état de santé et au stade de développement du nouveau-né, tels que des massages légers, des paroles ou des chansons douces, et le contact peau à peau, entraînent des évolutions positives des signes vitaux, et le nouveau-né commence alors à établir un contact visuel et à maîtriser les mouvements de ses membres.

L'initiative Hôpitaux amis des bébés a été adaptée pour les soins aux nouveau-nés malades et de petit poids (15), et est en conformité avec les normes de l'approche IFCDC (Figure 2). Elle encourage les parents à participer directement aux soins courants et à pratiquer fréquemment le contact peau à peau ou la MMK. Elle promeut également l'allaitement maternel exclusif, au sein ou par du lait tiré.

L'approche IFCDC vise aussi à réduire la stimulation négative associée au bruit fort et aux lumières vives, regroupe les procédures médicales dans le temps et respecte les cycles de sommeil du nourrisson dans la planification des soins et de l'alimentation. Elle permet la présence de la mère lors des interventions, évite la pression et les substances nocives sur la peau du nourrisson, et dispose de protocoles pour les émollissants et l'utilisation prudente d'adhésifs pour les nouveau-nés. Les familles disposent d'un soutien pour prodiguer à leur nourrisson des soins adaptés aux différents stades de développement.

SUÈDE:

« Zéro séparation » entre les nourrissons malades et de petits poids et les personnes qui s'en occupent

À l'hôpital de recours de l'Université d'Uppsala, l'unité de soins intensifs néonataux a des principes forts liés à l'approche IFCDC. Comme le dit l'infirmier/infirmière en chef en néonatalogie, « Lorsque l'on fait souvent quelque chose, on devient bon pour cela ». Le zéro séparation est pratiqué immédiatement après les accouchements par voie basse et par césarienne et même pour les nouveau-nés prématurés, qui peuvent recevoir une assistance respiratoire et être mis en contact peau à peau avec leur mère dans la salle d'accouchement.

Les personnels hospitaliers ont cherché des solutions pratiques pour maintenir la mère et le nouveau-né ensemble. Les nourrissons qui ne sont pas très malades sont pris en charge au sein de la maternité, mais s'ils doivent être transférés vers l'unité de soins intensifs néonataux, les familles bénéficient d'un environnement accueillant. Un lit pour un parent est placé à côté de chaque lit de nourrisson, et toute la famille a la possibilité de rester ensemble grâce à des chambres familiales et à l'absence de restrictions de visite pour les amis et les proches. La sœur ou le frère aîné d'un nouveau-né peut même séjourner dans l'unité, avec des services éducatifs et des espaces de jeux à disposition. Le rôle des infirmiers et infirmières a changé ; ils ne

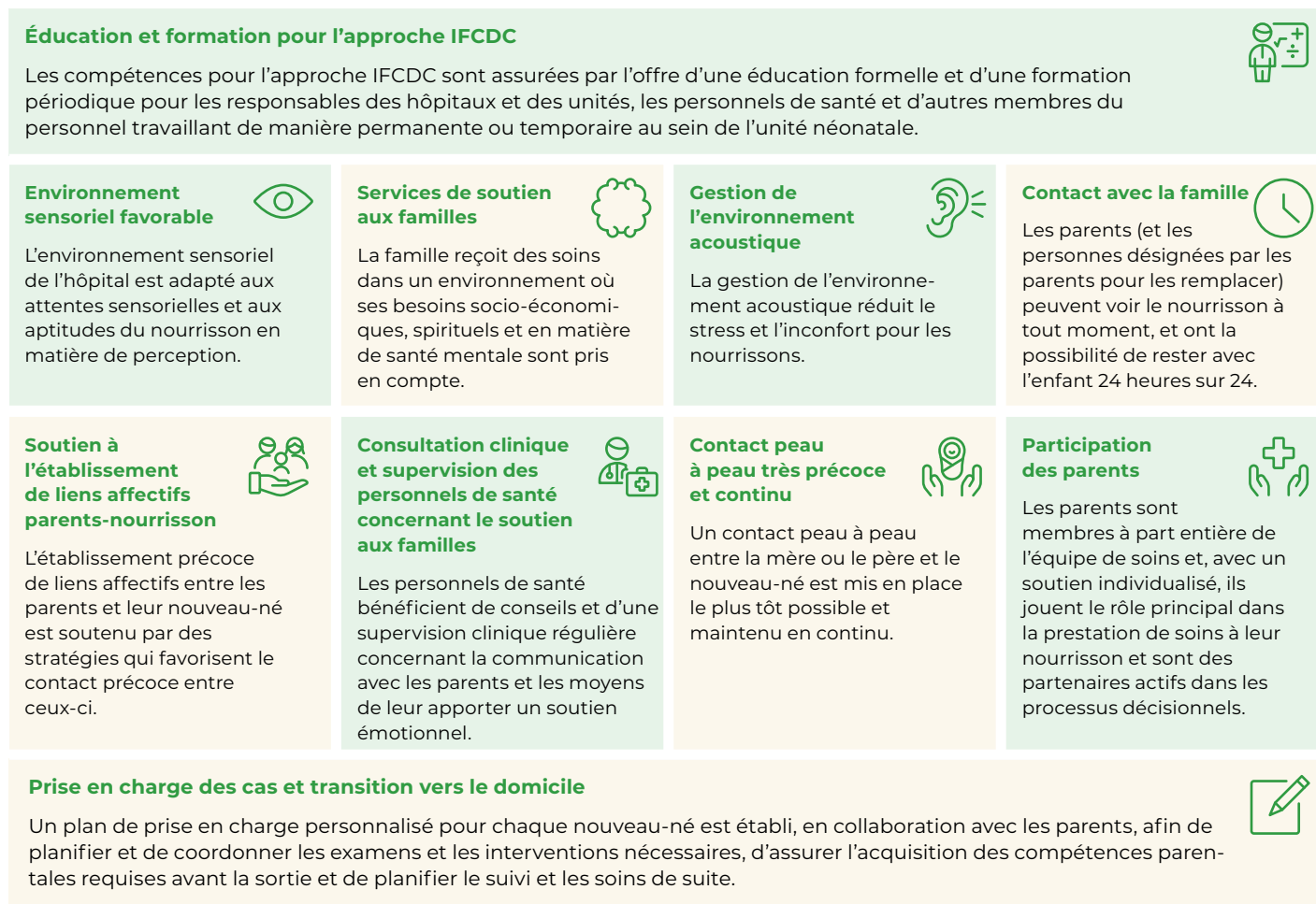
s'occupent plus directement du nouveau-né mais éduquent et soutiennent les parents pour qu'ils soient en mesure de le faire. Les soins peau à peau sont renforcés en n'habillant pas le nourrisson, car il a été constaté que les vêtements constituaient un obstacle majeur. L'approche IFCDC est étayée par les résultats de travaux de recherche ainsi que par les prestations parentales en Suède, grâce auxquelles les deux parents peuvent consacrer leur temps aux soins du nouveau-né s'il a besoin de soins intensifs, car ils n'ont pas besoin de travailler pendant son séjour à l'hôpital. Les congés de maternité et de paternité commencent après la sortie de l'enfant. Un soutien fort de la société est nécessaire pour garantir le respect du droit de tous les nourrissons, même en soins intensifs, d'avoir au moins un parent toujours avec eux. En janvier 2020, la Suède a été l'un des premiers pays au monde à aller au-delà de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, pour l'intégrer pleinement dans le droit suédois.

Référence : Roué J-M, Kuhn P, Maestro ML, Maastrup RA, Mitanchez D et al. Eight principles for patient-centred and family-centred care for newborns in the neonatal intensive care unit. Arch Dis Child-Fetal and Neonatal Edition. 2017;102(4):F364-8



Un grand frère fait du contact peau à peau en Suède. © Hôpital universitaire Karolinska, Stockholm (Suède)/Stina Klemming

Figure 2. Normes pour les soins de développement centrés sur le nourrisson et la famille (IFCDC)



Adapté d'après : *European Foundation for the Care of Newborn Infants* (10).

Soutenir la méthode « mère kangourou »

La MMK est un moyen très efficace pour fournir toutes les composantes des soins de soutien du développement aux nouveau-nés prématurés et de faible poids de naissance, même lorsqu'ils sont malades (16). Elle comprend le contact peau à peau continu ou prolongé entre le nouveau-né et la mère, le père ou une autre personne qui s'occupe de l'enfant à titre principal. Elle soutient l'allaitement maternel exclusif, au sein ou par du lait tiré. Elle favorise en outre la sortie précoce d'un établissement de santé.

La MMK renforce la perception positive des parents à l'égard de leur nourrisson de petit poids, leur capacité à identifier les signaux de leur enfant et à y répondre, ainsi que leur confiance dans la prestation de soins. Elle offre un environnement sensoriel approprié pour le nouveau-né grâce à des gestes délicats, au son des voix des personnes qui s'occupent de lui et à une stimulation douce. Les nouveau-nés présentent moins d'hypothermie, moins d'infections, une respiration plus stable et un meilleur sommeil.

La MMK est bénéfique pour les familles sur le plan émotionnel et même d'un point de vue financier. Elle est associée à une augmentation de la survie des nouveau-nés, à une amélioration du neurodéveloppement et à une diminution de la durée de séjour à l'hôpital. Les personnes s'occupant de nouveau-nés ressentent moins d'anxiété, ce qui se traduit par une incidence plus faible de la dépression post-partum. Elle apporte également des bénéfices à long terme pour le nourrisson sur les plans cognitif, comportemental et social, notamment une meilleure fréquentation scolaire, une diminution des comportements antisociaux et des salaires horaires plus élevés. Ces effets sont amplifiés par une durée accrue du contact peau à peau et par la participation des pères.

La MMK est généralement mise en place dans les établissements de santé, mais elle a également été soutenue avec succès par des prestataires formés dans la communauté. Après la sortie de l'établissement de santé, la MMK peut être poursuivie à domicile avec un soutien et un suivi adéquats. Les unités

de soins intensifs néonataux peuvent soutenir sa mise en œuvre en toute sécurité, dans le cadre de soins centrés sur le nourrisson et la famille (17).

Transformer les unités de soins intensifs néonataux

Il est très important de faire participer aux soins courants les personnes s'occupant de nouveau-nés ayant besoin de soins spéciaux ou intensifs. Ces nourrissons sont particulièrement vulnérables, et leur cerveau et leur corps immatures bénéficient de la proximité et des soins affectueux de leur mère, leur père et/ou d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Le maintien dans la même chambre du nouveau-né et de la personne qui s'en occupe doit devenir la norme, l'objectif étant le zéro séparation. La prestation de soins couplés mère-nouveau-né, c'est-à-dire que la mère reçoit les soins médicaux dont elle a besoin tout en étant avec le nourrisson en soins intensifs néonataux, a été mise à l'essai en Scandinavie (18). De nouvelles données provenant de l'Éthiopie, du Ghana, de l'Inde, du Malawi et du Nigéria montrent que cette approche

est également réalisable et très efficace dans les pays à revenu faible et intermédiaire (17).

Afin de soutenir les personnes s'occupant d'un nouveau-né qui a besoin de soins spéciaux ou intensifs, il faut notamment les encourager à se concentrer sur ce qu'elles sont en mesure de lui apporter, comme le confort, le lien, la stimulation et la sécurité émotionnelle. Avec le soutien adéquat des prestataires de soins, elles apprennent rapidement à prendre soin de leur nouveau-né malade ou de petit poids : changer ses couches, le nourrir à l'aide de lait maternel, le mettre en contact peau à peau et lui prodiguer des soins attentifs lorsqu'il est éveillé et actif. Cette participation active renforcera leur confiance et favorisera l'établissement de liens affectifs. Un soutien par les pairs peut être apporté par des mères plus expérimentées présentes dans le service.

Faciliter une transition sans heurt vers les soins à domicile

Lorsque les parents s'exercent à la pratique des soins attentifs à l'hôpital, ils renforcent leurs compétences et leur confiance pour être plus à même de prendre soin de leur nourrisson à la maison. Un plan de prise en charge personnalisé, précisant l'importance et le calendrier des examens et des interventions de suivi, doit être établi en collaboration avec les parents et les prestataires de soins de santé primaires dans la communauté. Les parents doivent se sentir prêts à prodiguer tous les soins de suite courants dont leur enfant a besoin avant sa sortie de l'hôpital. Le soutien familial est essentiel pour éviter que la mère se fatigue excessivement, c'est pourquoi d'autres personnes s'occupant du nourrisson doivent être impliquées dans la préparation de la transition vers les soins à domicile.

Renforcer le système de santé

Créer un environnement favorable pour des soins en services internes qui soutiennent le développement

Pour prodiguer des soins de soutien du développement, il faut des espaces familiaux établis, des lits, des chaises, de l'eau, des toilettes, de la nourriture ou des endroits pour cuisiner, ainsi que des buanderies pour permettre aux mères, aux pères

et aux autres aidants familiaux de rester avec leurs nouveau-nés. Il est également nécessaire de disposer d'installations pour le tirage du lait maternel et sa conservation en toute sécurité, d'ustensiles et de soutien pour l'alimentation au gobelet, et d'un accès à du lait maternel provenant de donneuses, lorsque cela est possible et approprié. Dans de nombreux contextes, la réorganisation des espaces dans les services doit faire partie d'un engagement renouvelé à répondre aux exigences en matière de soins attentifs.

Investir dans les personnels de santé

Même lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés en matière de personnels de santé, les pays peuvent prendre des mesures pour renforcer les ressources humaines pour la santé des nouveau-nés. Il est nécessaire d'investir dans une équipe stable de médecins, de personnel infirmier et d'autres personnels de santé associés pour créer un environnement favorable (19). Dans les unités de soins spéciaux et intensifs, les équipes doivent comprendre des membres ayant des compétences spécialisées dans le domaine néonatal et une bonne compréhension des besoins physiologiques, psychosociaux, émotionnels et spirituels des nouveau-nés et de leurs familles. L'établissement d'une collaboration fructueuse entre les parents et les personnels de santé se fonde sur un respect mutuel lors des interactions, une écoute active et une communication rigoureuse, ainsi que sur une prise de décisions partagée, dans le but d'accroître la confiance des parents pour qu'ils deviennent les principaux pourvoyeurs de soins. Les personnels de santé ont également besoin de systèmes de soutien fonctionnels et d'une culture de travail positive et saine, avec une supervision de soutien et suffisamment de temps pour leur permettre d'être motivés pour offrir des soins de développement centrés sur le nourrisson et la famille, notamment un soutien émotionnel.

Assurer un suivi approprié

Il est très important de surveiller la croissance et le développement et de dépister certaines affections, notamment les troubles visuels et auditifs, chez les nourrissons à risque après des soins spéciaux ou intensifs néonataux ; des visites doivent être planifiées pour cela. L'accès aux services sociaux, aux congés payés et au soutien par les pairs améliorera

l'expérience des parents, tout comme la présence d'un prestataire de soins de santé primaires qui peut faciliter l'accès à des soins dans les disciplines concernées, en fonction des besoins. Lorsque les agents et agentes de santé communautaires sont bien intégrés dans un système de soins de santé primaires, ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la fourniture d'un soutien à domicile. Il a également été démontré que le soutien par les pairs améliore la capacité et la confiance des personnes à s'occuper d'un nourrisson vulnérable. Ce soutien peut être offert individuellement ou dans le cadre de groupes d'entraide, en personne ou au moyen de technologies numériques. Les organisations de parents dont la mission consiste à améliorer les soins aux nouveau-nés malades et de petit poids contribuent de manière importante à la progression de la qualité des soins aux nouveau-nés et fournissent des ressources utiles aux parents confrontés à ces situations.

Mettre à jour l'ensemble des prestations de base pour la couverture sanitaire universelle

Afin de mettre en œuvre toutes les dispositions de l'approche IFCDC et d'améliorer l'accès à ces services, les interventions pertinentes doivent être incluses dans les ensembles de prestations de base pour les soins de santé primaires et la couverture sanitaire universelle. Cela permettra aux prestataires de soins publics et privés de couvrir les coûts des soins pour le nouveau-né et la personne qui s'en occupe, évitant ainsi aux familles de rencontrer des difficultés financières.



Le contact peau à peau fait sourire un père et ses jumeaux nouveau-nés.
© Fundación Canguro/Fondation Kangourou, Bogotá (Colombie)

PHILIPPINES :

Soins aux nouveau-nés malades et de petit poids intégrés à l'ensemble de prestations de l'assurance-maladie nationale

La MMK a été mise en œuvre pour la première fois au Dr. Jose Fabella Memorial Hospital à Manille en 1999, à la suite de la formation d'une néonatalogiste et d'une infirmière de l'unité de soins intensifs néonataux par la Fundación Canguro de Colombie. L'engagement de la direction de l'hôpital a été le premier pas vers l'adoption d'une politique visant à proposer la MMK pour les nouveau-nés prématurés et de faible poids de naissance.

À la suite de cette première formation, la création d'un comité de la MMK au sein de l'hôpital pour superviser et gérer la mise en œuvre du programme a permis de mener à bien plusieurs actions : 1) formation d'une équipe de base de formateurs et formatrices qui a formé tous les autres membres du personnel de santé et des professions connexes ; 2) accompagnement des membres du personnel sur le terrain ; 3) suivi et évaluation par le biais de travaux de recherche et d'audits ; et 4) élaboration d'une politique de l'hôpital. En 2004, un mémorandum d'accord avec le Département de la santé de la ville de Manille a facilité la poursuite des soins après la sortie de l'hôpital pour les personnes pratiquant la MMK grâce à la participation communautaire. D'autres établissements de santé de la ville ont mis en œuvre ces mêmes actions, et le premier

réseau de services associés à la MMK a été officialisé en 2005.

Consciente de l'impact de la MMK sur la survie des nouveau-nés malades et de petit poids, la formatrice principale à la MMK a poursuivi ses efforts de sensibilisation grâce à la création de la Kangaroo Mother Care Foundation aux Philippines en 2008. Le processus de mise en place de programmes de MMK centrés dans des établissements de santé et avec des liens au sein des communautés, et de certification des établissements en tant que centres d'excellence en matière de MMK a été reproduit dans toutes les régions des Philippines. La fondation a été créée initialement en tant qu'organisation non gouvernementale indépendante, mais elle a été soutenue à partir de 2013 par des associations professionnelles, des partenaires de développement mondiaux et le Ministère de la santé. La MMK a été intégrée à l'ensemble d'interventions des soins aux nouveau-nés (Care for small babies) par le Ministère de la santé en 2016, ce qui a conduit à son adoption au sein de l'ensemble de prestations de l'assurance-maladie nationale pour les nouveau-nés prématurés et de petit poids en 2017.

Pour en savoir plus sur la MMK aux Philippines, consulter le site Web : <http://www.kangaroomothercareph.org>.

ÉTUDE MULTI-PAYS :

L'application immédiate de la méthode « mère kangourou » sauve des vies

Un essai contrôlé randomisé mené dans cinq hôpitaux du Ghana, de l'Inde, du Malawi, du Nigéria et de la République-Unie de Tanzanie a montré que l'application de la MMK immédiatement après la naissance pour les nouveau-nés ayant un poids de naissance compris entre 1,0 et 1,799 kg réduisait la mortalité de 25 %. Ces nourrissons de très petit poids, pris en charge en unités de soins intensifs néonataux, recevaient des soins prodigués par leurs mères, en étroite coordination avec le personnel médical. Grâce à la méthode des soins couplés mère-nouveau-né, cette étude a démontré qu'il est possible de modifier l'environnement hospitalier pour permettre aux mères d'être avec leurs nouveau-nés afin d'appliquer la MMK de manière continue et de recevoir leurs propres soins postnatals sans être séparées de leur enfant. Lorsqu'une mère ne se sentait pas bien, une autre personne s'occupant de l'enfant à titre principal, comme le père, était sollicitée pour garantir une continuité de l'application de la méthode kangourou jusqu'à ce que la mère soit à nouveau en mesure de s'occuper du nourrisson. D'après les résultats obtenus, on estime que l'application de la MMK immédiatement après la naissance peut permettre de sauver jusqu'à 150 000 vies supplémentaires chaque année, par rapport à la recommandation actuelle de ne démarrer son application qu'une fois que le nouveau-né est stable.

Pour plus d'informations, consulter la publication (17).



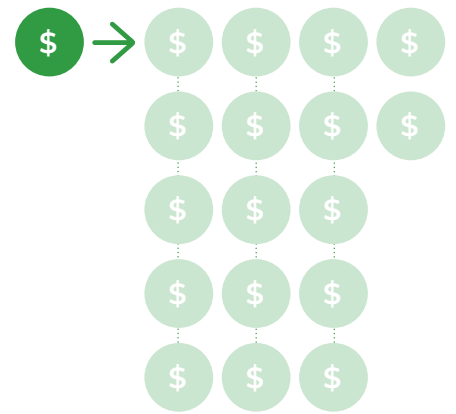
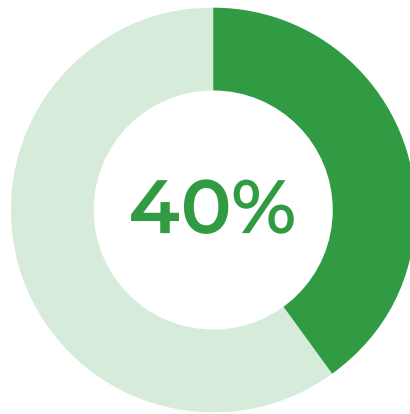
Une infirmière aide une mère à établir le contact peau à peau immédiatement après la naissance. © Fundación Canguro/ Fondation Kangourou, Bogotá (Colombie)

Le saviez-vous ?

Le cerveau humain se forme à

80%

dans les trois premières années de la vie.



Les soins et le soutien apportés au cours des toutes premières années par les parents et les autres personnes auxquelles sont confiés les enfants sont essentiels à un bon développement cérébral.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 250 millions d'enfants de moins de cinq ans, soit plus de 40 % de la population infantile, ont plus de risques de ne pas réaliser leur potentiel de développement parce qu'ils sont pauvres et victimes de négligence (20).

Chaque dollar supplémentaire investi dans le développement des jeunes enfants peut « rapporter » entre 6 et 17 dollars américains (21).

0-3

Le cerveau se développe plus vite entre la conception et l'âge de trois ans qu'à tout autre moment.



Dans la prime enfance, les parents, le cercle familial et les autres personnes auxquelles le jeune enfant est confié sont les plus proches de lui et donc les mieux à même de lui prodiguer des soins attentifs. Afin que les aidants qui s'occupent des enfants aient le temps et les moyens requis pour leur dispenser des soins attentifs, il faut mettre en place des politiques, des services et diverses formes de soutien communautaire.



Des soins attentifs améliorent la santé, la productivité et la cohésion sociale tout au long de la vie et les bénéfices se répercutent sur la génération suivante.

Encourager, protéger et soutenir les enfants et ceux qui s'en occupent est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.

LIBAN :

Innover en faveur des soins attentifs dans les unités de soins intensifs néonataux

Une participation accrue des familles à la prestation des soins aux nouveau-nés prématurés et malades présentant un risque élevé est encouragée dans les unités de soins intensifs néonataux de l'American University of Beirut Medical Center au Liban. Au lieu d'être séparés de leur enfant, les mères et les pères participent aux soins hospitaliers courants. Les caractéristiques de l'unité adaptée aux familles sont les suivantes :

- Tous les nourrissons qui doivent être placés en couveuse sont positionnés de manière à recréer la position in utero.
- L'environnement de l'unité est calme, avec un éclairage tamisé et des moments de silence.
- Les mères donnent leur lait maternel dès que possible.
- Les nourrissons parviennent à téter de manière plus précoce grâce à une stimulation non nutritive de la bouche.
- Les mères et les pères apprennent à porter leurs nourrissons avec précaution en utilisant leurs mains pour simuler les gestes.
- Une fois que leurs nourrissons sont stables, les mères et les pères les mettent en contact peau à peau le plus possible.
- Les mères et les pères apprennent à prodiguer les soins courants à leurs nourrissons, et leur parlent et chantent doucement.

- Les nouveau-nés reçoivent des soins de développement personnalisés en plus du suivi de leur développement physique.
- Une salle familiale permettant aux mères de se reposer est adjacente à l'unité.

La aplicación de este enfoque, que se basa en el Programa Individualizado de Evaluación y Atención para el Desarrollo del Recién Nacido, ha aumentado la implicación de los progenitores y el vínculo afectivo con sus hijos, y además se ha mejorado su capacidad para responder a las señales sutiles de los lactantes más débiles. El personal de enfermería y medicina mantiene una actitud positiva y facilita la transición hacia un modelo de atención centrado en la familia. Los profesionales de la unidad están evaluando los resultados de este método en el desarrollo de los niños y prevén que aquellos cuyos padres participan activamente en la atención y la estimulación tempranas presenten menos retraso del desarrollo que los que son atendidos en unidades convencionales orientadas a las tareas.

Référence : Als H, McNulty GB. The newborn individualized developmental care and assessment program (NIDCAP) with kangaroo mother care (KMC): comprehensive care for preterm infants. *Current Women's Health Reviews*. 2011; 7(3):288-301.

Charafeddine L, Masri S, Sharafeddin SF, Kurdahi Badr L. Implementing NIDCAP training in a low-middle-income country: comparing nurses and physicians' attitudes. *Early Hum Dev*. 2020;147:105092.



Les parents créent un lien avec leur nouveau-né par le contact peau à peau. © Université américaine de Beyrouth, Beyrouth (Liban)/Lama Charafeddine

COLOMBIE :

Maintien de la méthode « mère kangourou » pendant la pandémie de COVID-19

Depuis 1994, la *Fundación Canguro*, basée à Bogotá en Colombie, promeut l'application de la MMK, une méthode fondée sur des données probantes qui modifie l'approche des soins néonataux. À la suite de l'identification du premier cas de COVID-19 dans le pays, le Gouvernement de la Colombie a publié une série de restrictions et une déclaration d'urgence sanitaire nationale. Les médecins et le personnel infirmier du programme de MMK de l'Universidad Javeriana s'inquiétaient des conséquences potentielles du virus, mais ils étaient également convaincus du fait que la MMK était le meilleur moyen de soutenir les nouveau-nés prématurés et de faible poids de naissance.

Presque immédiatement après le début de la pandémie, la Asociación Colombiana de Neonatología, le Ministère colombien de la santé et la Fundación Canguro ont publié la première série de recommandations pour la poursuite sans risque des programmes de MMK. Ces recommandations portaient sur les mesures de sûreté biologique pour les personnes s'occupant d'enfants et le personnel, sur la prise en charge des mères asymptomatiques et symptomatiques et sur la logistique des consultations externes. Contrairement à la situation dans d'autres pays, dans lesquels les lignes directrices officielles exigeaient que les mères infectées ou présumées infectées par le virus de la COVID-19

soient séparées de leurs nouveau-nés, le travail mené en collaboration étroite par ces institutions a permis de maintenir les pratiques de maintien du nouveau-né dans la chambre de sa mère. En conséquence, 50 indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant ont été maintenus aux niveaux observés avant la pandémie et une augmentation de l'allaitement maternel a été constatée, peut-être parce que les parents avaient conscience de son rôle important dans le développement du système immunitaire de l'enfant. Les membres du personnel ont continué à encourager l'allaitement maternel et à déconseiller la séparation mère-enfant pour les mères positives à la COVID-19, conscients des bénéfices considérables de la méthode MMK pour la mère et l'enfant. De plus amples informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour maintenir la MMK pendant la pandémie de COVID-19 sont disponibles dans l'étude de cas complète.

Référence : Hackett K, Proulx K, Alvarez A, Whiteside P, Omoeva C. Case studies of programs to promote and protect nurturing care during the COVID-19 pandemic. FHI360, The LEGO Foundation; 2021 (<https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-lego-case-study-nurturing-care-report.pdf>, consulté le 21 avril 2021).



Un nourrisson regarde avec curiosité une infirmière en Côte d'Ivoire.
© UNICEF/UNI312809/Dejongh

Conclusion

Les premières heures, les premiers jours et les premières semaines après la naissance constituent des moments déterminants pour la survie, la santé et le développement d'un nouveau-né. Des connaissances et des outils sont disponibles pour que chaque nouveau-né bénéficie de soins attentifs auxquels ses parents et les autres personnes s'occupant de lui participent directement. Pour créer un environnement favorable aux soins attentifs, il est nécessaire d'investir dans les politiques, les systèmes de santé et la sensibilisation des communautés. Alors que de plus en plus de nouveau-nés survivent, nous devons à présent nous assurer qu'ils parviennent également à s'épanouir. Ceci est particulièrement important pour les nouveau-nés les plus à risque : les nouveau-nés malades et de petit poids qui sont plus susceptibles de mourir ou d'être atteints de maladies.

La pandémie de COVID-19 a provoqué un bouleversement de la vie des familles et des communautés, et les systèmes de santé ont dû s'adapter pour maintenir les services essentiels. Aucune donnée probante n'a été présentée attestant la présence de virus infectieux capable de se répliquer et d'infecter d'autres cellules ou la transmission par le lait maternel (22). L'étude de cas portant sur la Colombie montre qu'il est sûr de maintenir les pratiques décrites dans la présente note thématique dans le contexte de la COVID-19 et de continuer à prodiguer des soins attentifs aux nouveau-nés, à condition que des mesures de protection adéquates soient prises.

Des normes de soins (3,10) sont disponibles pour orienter les mesures que les responsables des politiques, les gestionnaires des programmes de santé et d'autres personnes doivent prendre. Des indicateurs de base permettant de mesurer l'amélioration de la qualité des soins aux nouveau-nés sont en cours d'élaboration pour inclure les nouveau-nés malades ou de petit poids. Il est grand temps que tous les nouveau-nés reçoivent des soins attentifs, et aucun nourrisson ne doit être laissé de côté.

Rappeler

Le premier mois de vie est une période déterminante pour la croissance et le développement sains des enfants.

Renforcer

Il est primordial d'améliorer la qualité des soins que les mères et les nouveau-nés reçoivent dans les services de maternité et de soins néonataux, conformément à des normes bien définies.

Compléter

Il est possible, grâce aux soins de développement centrés sur le nourrisson et la famille, de prodiguer des soins attentifs aux nouveau-nés malades ou de petit poids qui ont besoin de soins spéciaux ou intensifs, y compris dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

REMERCIEMENTS

ÉQUIPE DE RÉDACTION :

Bernadette Daelmans, Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et vieillissement, Organisation mondiale de la Santé (OMS/MCA), Louise Tina Day (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Ornella Lincetto (OMS/MCA).

Les auteures tiennent à remercier Nathalie Charpak (Fundación Canguro, Bogotá, Colombie), Arti Maria (ABVIMS & Dr Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Inde), Lama Charafeddine (Université américaine de Beyrouth, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Beyrouth, Liban), Socorro De Leon-Mendoza (Kangaroo Mother Care Foundation Philippines, Inc., Philippines), Ylva Thernström Blomqvist (Hôpital universitaire, unité de soins intensifs néonataux, Uppsala, Suède) et Bjørn Westrup (département de la santé de la femme et de l'enfant, Karolinska Institutet, Suède) pour leurs révisions du manuscrit et les courtes présentations qui illustrent de quelle manière des soins attentifs sont prodigués aux nouveau-nés malades et de petit poids dans divers contextes.

Des remerciements sont également adressés à Anne Detjen (UNICEF), Maya Elliott (UNICEF), Leah Greenspan (Agence des États-Unis pour le développement international [USAID]), Tedbabe Degefie Hailegebriel (UNICEF), Lily Kak (USAID), Romilla Karnati (Momentum Country and Global Leadership/Save the Children), Catherine Kirk (Save the Children), Neena Khadka (Momentum Country and Global Leadership/Save the Children), Jane Lucas (consultante), Silke Mader (European Foundation for the Care of Newborn Infants), Sheila Manji (OMS/MCA), Alison Morgan (Mécanisme de financement mondial), Karen New (consultante), Susan Niermeyer (USAID), Ana Nieto (UNICEF) et Theresa Shaver (USAID) pour leur examen minutieux des versions préliminaires de cette note thématique.

APPUI ÉDITORIAL:

Peggy Henderson ; Sheila Manji

Ressources utiles

Chaque nouveau-né

plate-forme d'action conjointe pour la réduction des décès de nouveau-nés et des mortinaissances évitables, grâce à la mise en œuvre du Plan d'action « Chaque nouveau-né » approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 2014.

<https://www.healthynewbornnetwork.org/issue/every-newborn/>

Réseau pour l'amélioration de la qualité des soins en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant (*Network for Improving the Quality of Care for Maternal, Newborn and Child Health*)

vaste partenariat de gouvernements, de partenaires de mise en œuvre et d'organismes de financement engagés qui unissent leurs efforts pour garantir que chaque femme enceinte, chaque nouveau-né et chaque enfant reçoive des soins de qualité, respectueux de l'équité et de la dignité.

<https://ewene.org/accelerate-maternal-and-newborn-survival/quality-of-care-network/>

Global Alliance for Newborn Care (GLANCE)

réseau visant à améliorer la santé du nouveau-né et de la mère dans le monde entier, à garantir que des soins attentifs sont prodigués dans tous les contextes et à permettre à chaque fille, chaque femme et chaque parent de disposer des informations nécessaires pour faire des choix et prendre des décisions avant la conception, pendant la grossesse et lors de la naissance, ainsi que durant le suivi et les soins de suite après la sortie de l'hôpital.

<https://www.glance-network.org/>

Every Preemie

projet conçu pour proposer des approches pratiques, porteuses et évolutives pour élargir le recours à des interventions dans le cadre des naissances prématurées et de l'insuffisance pondérale à la naissance dans 24 pays, principalement en Afrique et en Asie, fournissant des ressources utiles.

<https://www.gapps.org/Home/EveryPreemie>

Newborn Essential Solutions and Technologies (NEST360)

alliance multidisciplinaire qui travaille avec les gouvernements africains pour permettre à chaque hôpital d'Afrique de prodiguer des soins vitaux de haute qualité aux nouveau-nés malades et de petit poids. NEST360 est un modèle fondé sur des données probantes pour la mise en œuvre de systèmes de santé durables à l'échelle nationale, notamment en comblant les lacunes en matière de ressources humaines, de technologies et de données.

<https://www.nest360.org>

Références

1. Survive and thrive: transforming care for every small and sick newborn. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241515887>, consulté le 31 mai 2021).
2. United Nations Interagency Working Group for Child Mortality Estimation. Levels and trends in child mortality. New York: UNICEF; 2020 (<https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/>, consulté le 31 mai 2021).
3. Normes destinées à améliorer la qualité des soins des nouveau-nés malades et de petit poids dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/342994>, consulté le 31 mai 2021).
4. The Global Health Observatory (<https://www.who.int/data/gho/>) et le Maternal, newborn, child and adolescent health and ageing data portal (<https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/global-strategy-data>).
5. Chawanpaiboon S, Vogel JP, Moller A, Lumbiganon P, Petzold M et al. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. *Lancet Glob Health*. 2019;7(1):e37-e46. doi:10.1016/S2214-109X(18)30451-0.
6. UNICEF, WHO. UNICEF-WHO low birthweight estimates: levels and trends 2000–2015. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/news/item/07-06-2019-joint-low-birthweight-estimates-levels-and-trends-2000-2015>, consulté le 31 mai 2021).
7. Lawn JE, Davidge R, Paul VK, Von Klyander S, De Graft Johnson J et al. Born too soon: care for the preterm baby. *Reprod Health*. 2013;10(Suppl 1):S5. (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24625233/>, consulté le 31 mai 2021).
8. Recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016 (<https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789241549912>, consulté le 31 mai 2021).
9. Altimier L, Phillips R. The Neonatal Integrative Developmental Care Model: advanced clinical applications of the seven core measures for neuroprotective family-centered developmental care. *Newborn and Infant Nursing Reviews*. 2016;16(4):230–44.
10. European Standards of Care for Newborn Health. Infant and family-centred developmental care. European Foundation for the Care of Newborn Infants [Site Web] (<https://newborn-health-standards.org/standards/standards-english/infant-family-centred-developmental-care/>, consulté le 31 mai 2021).
11. OMS, UNICEF. Orientations de mise en œuvre : protection, encouragement et soutien de l'allaitement dans les établissements assurant des services de maternité et de soins aux nouveau-nés : révision de l'Initiative Hôpitaux amis des bébés 2018. Genève, Organisation mondiale de la Santé, UNICEF, 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241513807>, consulté le 31 mai 2021).
12. Gelaye B, Rondon MB, Araya R, Williams MA. Epidemiology of maternal depression, risk factors, and child outcomes in low-income and middle-income countries. *Lancet Psychiatry*. 2016;3(10):973–82.
13. WHO recommendations for postnatal care of the mother and the newborn. Geneva: World Health Organization, 2013 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506649>, consulté le 31 mai 2021).
14. Seale AC, Blencowe H, Manu AA, Nair H, Bahl R et al. Estimates of possible severe bacterial infection in neonates in sub-Saharan Africa, south Asia, and Latin America for 2012: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis*. 2014;14(8):731–41. doi:10.1016/S1473-3099(14)70804-7.
15. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: the Baby-friendly Hospital Initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva: World Health Organization, UNICEF, 2020 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240005648>, consulté le 31 mai 2021).
16. Conde-Agudelo A, Diaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;(8):CD002771.
17. WHO study group on KMC. Immediate “Kangaroo Mother Care” and the survival of infants with low birth weight. *N Engl J Med*. 2021;384:2028–38. doi:10.1056/NEJMoa2026486.
18. Klemming S, Lilliesköld S, Westrup B. Mother-newborn couplet care from theory to practice to ensure zero separation for all newborns. *Acta Paediatr*. 2021;00:1–7. doi:10.1111/apa.15997.
19. Stratégies en ressources humaines visant à améliorer la prestation des soins néonataux dans les établissements de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/345348>, consulté le 31 mai 2021).
20. Chunling L, Black MM, Richter LM. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. *Lancet Glob Health*. 2018;4(12):e916–22. doi:10.1016/S2214-109X(16)30266-2.
21. Heckman JJ. There's more to gain by taking a comprehensive approach to early childhood development. Chicago: The Heckman Equation; 2017 (https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf, consulté le 31 mai 2021).
22. Rollins N, Minckas N, Jehan F, Lodha R, Raiten D et al. A public health approach for deciding policy on infant feeding and mother–infant contact in the context of COVID-19. *Lancet Glob Health*. 2021;9:e552–7. doi:10.1016/S2214-109X(20)30538-6.
23. OMS, UNICEF, Groupe de la Banque mondiale. Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir afin de transformer la santé et le potentiel humain. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (<https://iris.who.int/handle/10665/325724>, consulté le 31 mai 2021).

Soins attentifs pour le développement de la petite enfance

Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à SURVIVRE et à S'EPANOUIR afin de TRANSFORMER la santé et le potentiel humain (23). Il s'appuie sur les dernières données relatives aux différents stades du développement du jeune enfant et aux politiques et interventions les plus efficaces pour améliorer son développement. L'OMS, l'UNICEF et le Groupe de la Banque mondiale ont défini ce cadre en collaboration avec le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, et le Réseau d'action pour le développement du jeune enfant et de nombreux autres partenaires afin d'établir une feuille de route pour réaliser les objectifs de développement durable ainsi que les objectifs Survivre, S'épanouir et

Soins attentifs pour le développement de la petite enfance

Transformer de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent. Lancé en 2018 avec la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ce cadre souligne : i) les raisons pour lesquelles les efforts visant à améliorer la santé, le bien-être et le capital humain doivent débiter dès les premières années, de la grossesse à l'âge de 3 ans ; ii) les principales menaces pour le développement dans la petite enfance ; iii) la façon dont les soins attentifs protègent les jeunes enfants contre les pires effets de l'adversité et favorisent leur développement physique, affectif, social et cognitif ; et iv) ce dont ont besoin les familles et les soignants pour prodiguer des soins attentifs aux jeunes enfants.



POUR PLUS D'INFORMATIONS

nurturing-care.org
ecdan.org

PARTICIPEZ À LA CONVERSATION

#NurturingCare
@NurturingCare

CONTACT

NurturingCare@who.int



Une mère et sa fille font la connaissance du nouveau membre de la famille en Mongolie.
© UNICEF/UN0198614/Njiokiktjien VII Photo



Soins attentifs pour chaque nouveau-né : note thématique [Nurturing care for every newborn: thematic brief]

ISBN (OMS) 978-92-4-011962-8 (version électronique)
ISBN (OMS) 978-92-4-011963-5 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 2025.
Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)